

סכמת X-CARE לטיפול בפצוע בודד

סבב ראשוני

במתאר "תחת-אש"

X

השב באש ותפוס מחסה
פכט"ת
"חלץ טפל!" (השג עליונות אש וחלץ פצוע במידה ולא מחלץ עצמאית)
אחרי הגעת הפצוע למחסה עודד פצוע לעצור דימומים מסכני חיים (עצור דימומים מסכני חיים במידה והפצוע מתקשה)
דיווח 5 המ' (מתי, מיקום, מנגנון, מספר פצועים, מצבם)
קדם את הפצוע למתאר מאוים-מאובטח

במתאר "מאויים-מאובטח"

C

הפשטה והפיכה (חובש לבד חשיפה מהירה חלקית)
עצירת לשט"דים מסכני חיים מידית (נקודת לחיצה, פאקינג וח"ע)
בדיקת הכרה - AVPU
בדיקת נתיב אוויר - פתיחת פה, סריקת פה, סילוק הפרשות
בדיקת קולות נשימה מהפה כולל הערכת נשימה (נחירות, חרחורים, צרידות/סטרידור, דום נשימה, קולות תקינים)
בדיקת שלמות פנים (שבר לסת עליונה עם תזוזה משמעותית, שבר לסת תחתונה קדמי דו-צדדי)
בדיקת שלמות צוואר קידמי (טראומה ישירה ללרינקס או לקנה)
בחדש לפגיעת עמ"ש - קיבוע ידני עד השלמת קיבוע מלא
מדידת לחץ דם - מד סטורציה (להתרשמות מדופק) - דופק רדיאלי (איכותי) - דופק קרוטידי (איכותי)

הגדר הולם
עמוק

הגדר האם קיים הולם עמוק
במידה ואפשר להתחיל פינוי בלי לפגוע במתן נפח, החל פינוי (דם מלא - פלזמה - הרטמן)
במידה ואי אפשר להתחיל מתן נפח במהלך הפינוי השג גישה והכן נפח לפני תחילת פינוי
● חובש במרחק יותר מ 15 דק' ממוצד דם ייתן הרטמן עד השגת דופק רדיאלי

AR

● אם A כבר בוצע אין צורך, אם לא, או בוצע לפני יותר ממספר שניות יש לבצע מחדש כמו שרשום ב C
חשיפת בית חזה
בדיקת קליקולות (מישוש וניקוש)
איתור פציעות בקידמת בית חזה (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)
איתור פציעות בבתי שחי (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)
מדידת נשימות 30 שניות (0-10, 10-20, 20-30, >30)
התרשמות ממאמץ נשימתי
1 יחס שאיפה / נשימה (נשימה יותר ארוכה / שאיפה יותר ארוכה)
2 רטרקציות
3 שימוש בשרירי עזר
סטורציה (איכות חמצון) אם לא לבדק

בדיקת בטן (סרוק במישוש מגרפה/כפפה רטובה ולחיצות לפי רבעים)
מדידת דופק 15 שניות (כמותי - איפה שהיה דופק ב C)
מדידת לחץ דם - מילוי קפילארי + צבע עור הזעה טמפרטורה
יציבות אגן (ניקוש)
מפשעה ואיזורי חיץ קידמיים (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)
סחיטת ירכיים (דפורמציה / דימום פנימי)
הפיכה וסריקה לאיתור פציעות מקו שיער עד נעליים (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)

E

בדיקת גפיים (תחושה / תזוזה / שלמות צורה)
שלילת עיניי דביבון
שלילת הפרשת CSF / דם מהאוזניים
שלילת סימני קרב
● אישונים (מורחבים / שווים / לא שווים / צרים)
איתור דימומים ודפורמציות (יד דרך שיער)

השלמת הפשטה
העלאה על אלונקה (מבנה - בד, חוץ - קשיחה)
עטיפה בשמיכת מילוט
סריקות ושימוש בתיק חפצים
דיווח מאסט (מנגנון, איזורי פציעה, סימנים ותסמינים, טיפולים שבוצעו)
השלמת 101

האם הפצוע בהלם עמוק?
ל"ד סיסטולי נמוך מ 90 מ"מ כ"ג
או
ל"ד שאינו ניתן למדידה
וגם
היעדר דופק רדיאלי
או
שינוי ברמת הכרה
(שאינו על רקע חבלת ראש או תרופות)

התוויות התייחסות ניהול נתיב אוויר בשלב ה C:
1 שבר לסת עליונה עם תזוזה משמעותית שתחסום את הנזופרינקס
2 גופים זרים לרבות שיניים שבורות או שברי עצמות
3 שבר לסת תחתונה קדמי דו-צדדי
4 טראומה ישירה ללרינקס או לקנה
5 חוסר הכרה
6 דום נשימה